

新・家庭医療専門医制度の改訂

ポートフォリオ 2 割削減とかかりつけ医機能報告制度

これは「楽になった」のか？
それとも「質がもっと問われる」のか？

今日の学習目標（15 分）

- 説明できる — 制度変更の具体的内容と背景
- 比較できる — 旧制度と新制度の差分を分析
- 立案できる — ポートフォリオ戦略を描ける

20 → 16

ポートフォリオ領域
2 割削減

Quick Poll

☒ 新・家庭医療専門医制度のポートフォリオを書いたことがある人？

☒ 「かかりつけ医機能報告制度」という言葉を聞いたことがある人？

☒ 第 17 回 JPCA 学術大会（2026 年 5 月・京都）に参加予定の人？

専門医制度と医療政策が同時に動いています。
「制度を知る」ことは、キャリア戦略そのものです。

何が変わった？

旧制度

20 領域

学会発表 3 件以上



新制度

16 領域

学会発表 2 件以上

領域が「消えた」のではなく、既存領域に統合された。
→ 1 つのポートフォリオに求められる多面性と深さがむしろ増している。

統合された旧領域：

- 複雑困難事例 → 多疾患併存 (4) 等
- プロフェッショナルリズム → 医療者自身のケア (16)
- セクシャルヘルス・思春期 → 各関連領域
- 緩和ケア・最終段階 → 長期的関係 (5)

コア 16 領域は変更なし

- 1. 未分化な健康問題
- 2. 予防医学・健康増進
- 3. 慢性疾患 4. 多疾患併存
- 5. 長期的全人的関係 6. 患者中心
- 7. 家族志向 8. 地域志向 PC
- ...16. 医療者自身のケア

かかりつけ医機能報告制度

2025 年 4 月施行 | 初回報告 : 2026 年 1-3 月 (G-MIS)

報告制度で求められる能力

- 17 診療領域・40 疾患対応力
- 在宅医療・訪問診療の提供体制
- 総合診療専門医の配置 (報告項目)



家庭医療専門医の研修

- 16 ポートフォリオ領域
- 包括的なプライマリ・ケア能力
- 地域志向のアプローチ

あなたの存在が、医療機関の「かかりつけ医機能」を高める。
家庭医療専門医の研修で培う能力 ≡ 報告制度で求められる能力。

ペアディスカッション

3 分ペアワーク + 1 分シェア | 問いを 1 つ選んでください

問い A 専攻医向け

16 領域になった今、残りの研修期間で
どの領域を「質の高い事例」として書きたいか？

問い B 研修医向け

かかりつけ医機能報告制度で求められる能力のうち
今の研修で意識的に伸ばせるものは何か？

問い C 指導医向け

ポートフォリオ領域が統合された今、
指導でどんな点を強調するか？

振り返りと持ち帰り

1. 量から質へ

20→16 領域の削減は、1 事例あたりの深さ・多面性を重視する方向

2. 制度と教育の融合

かかりつけ医機能報告制度と専門医研修は同じ方向を向いている

3. あなたの価値

総合診療 / 家庭医療専門医は、これからの医療制度で求められる存在

次のアクション

今週

JPCA 公式サイトで新 16 領域の詳細を確認

来月

第 17 回 JPCA 学術大会（5/29-31 京都）の演題募集チェック

今月中

指導医とポートフォリオ進捗を振り返る

自分のポートフォリオで一番自信のある領域と、
一番苦手な領域は何か？ 苦手な領域をどの臨床場面で経験できるか？